

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN

NO DOKUMEN	:	UDDP-MK-L2-004
VERSI	:	004
TANGGAL BERLAKU	:	15 SEPTEMBER 2025
TANGGAL KAJI ULANG	:	15 SEPTEMBER 2027
STATUS DOKUMEN	:	MASTER: ☒ SALINAN NO: ☐ 01

Disusun oleh Shaffa Auliya Hawwa, A.Md.Kes. Staf Pelulusan Produk UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan  Tanggal 28 Agustus 2025
Diperiksa oleh Frida Rosita, S.Si., M.Biomed. Kasubid. Kontrol Dokumen UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan  Tanggal 2 September 2025 DOKUMEN TERKENDALI Salinan No :
Disetujui oleh Mega Octavia, S.Si. Kasubid. Pemastian Mutu UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan  Tanggal 9 September 2025
Disahkan oleh dr. Sri Hartaty, M.Biomed. Manajer Kualitas UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanda tangan  Tanggal 12 September 2025

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN		Halaman : 1 dari 11 Nomor : UDDP-MK-L2-004 Versi : 004 Tgl. berlaku : 15 Sep 2025 Tgl. kaji ulang : 15 Sep 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini menggambarkan proses tentang:

- 1.1 Pelaporan dan penatalaksanaan insiden yang ditemukan pada bagian teknis (rekrutmen donor, seleksi donor, pengambilan darah, proses pengolahan, pengujian darah, penyimpanan dan distribusi) maupun bagian non teknis yang selalu harus dipantau, diselidiki, diperbaiki dan didokumentasikan
- 1.2 Penilaian tingkat risiko insiden yang terjadi dan dampaknya terhadap mutu, keamanan dan efektivitas darah dan komponen darah
- 1.3 Pengidentifikasian dan analisis akar penyebab serta penyiapan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP) memadai yang harus diambil untuk menghindari keberulangan penyimpangan yang sama

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh semua staf Unit Donor Darah Pusat (UDDP) untuk melaporkan insiden atau kejadian penyimpangan dan mencatatnya untuk diambil Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP).

2.1. Laporan Insiden harus meliputi:

- 2.1.1 Prosedur yang tidak diikuti dan terdapat potensi yang akan berdampak kepada kualitas dan keamanan staf, donor atau komponen darah dan produk yang dihasilkan oleh UDDP
- 2.1.2 Kesalahan sistem, bahan, peralatan
- 2.1.3 Kesalahan lingkungan terkait dengan standar yang telah ditetapkan (suhu, kelembapan, kebersihan, keamanan)
- 2.1.4 Keluhan pelanggan
- 2.1.5 Kejadian berat selama donor darah (reaksi transfusi dan efek samping donor darah yang berat)
- 2.1.6 Produk yang tidak sesuai spesifikasi
- 2.1.7 Kebutuhan untuk deviasi/penyimpangan yang terencana: di tengah rencana yang sudah dibuat, perlu dilakukan tindakan lain yang setara dari rencana awal
- 2.1.8 Kinerja pemasok atau permasalahan pemasok

2.2. Pencatatan TPP harus dimasukkan dalam Laporan Insiden dan semua pencatatan digunakan untuk kejadian berikut:

- 2.2.1 Investigasi dan rencana *Corrective and Preventive Action* (CAPA) diperlukan jika insiden yang terjadi itu kompleks dan melibatkan banyak bidang
- 2.2.2 Permasalahan yang terjadi dirasa tidak serius, namun terus berulang terjadi sehingga dapat berdampak serius.
- 2.2.3 Data atau pengawasan yang menunjukkan adanya kecenderungan terjadinya permasalahan serius, dimana hal ini belum terjadi, namun berpotensi terjadi di masa yang akan datang.

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN		Halaman : 2 dari 11
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	Nomor : UDDP-MK-L2-004 Versi : 004 Tgl. berlaku : 15 Sep 2025 Tgl. kaji ulang : 15 Sep 2027

3 Persyaratan Sistem Mutu

3.1 Butir 1.16 (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Persyaratan dasar CPOB adalah sebagai berikut: (j) setiap penyimpangan signifikan dicatat dengan lengkap, diinvestigasi dengan tujuan untuk menentukan akar masalah.

3.2 Butir 1.33 (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Harus tersedia suatu sistem untuk mengendalikan penyimpangan dan ketidaksesuaian. Analisis akar penyebab masalah yang tepat seharusnya diterapkan selama investigasi penyimpangan, dugaan kerusakan produk, dan masalah lain. Hal ini dapat ditentukan dengan menggunakan prinsip Manajemen Risiko Mutu (MRM). Dalam kasus di mana akar penyebab masalah sebenarnya tidak dapat diterapkan, dapat dipertimbangkan identifikasi terhadap beberapa akar penyebab masalah yang paling mungkin terjadi sehingga dapat ditetapkan tindakan yang diperlukan. Apabila faktor kesalahan manusia diduga atau diidentifikasi sebagai penyebab masalah, perlu dipastikan bahwa proses, prosedur, atau sistem yang berpotensi menimbulkan kesalahan atau masalah tidak diabaikan, jika terjadi. Tindakan perbaikan dan pencegahan yang tepat seharusnya diidentifikasi dan dilaksanakan sebagai respons terhadap terhadap hasil investigasi. Efektivitas tindakan tersebut seharusnya dipantau dan dinilai, sesuai prinsip MRM.

3.3 Butir 1.34 (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Manajemen puncak UPD dan Bank Plasma mengkaji sistem pengendalian penyimpangan secara berkala untuk memverifikasi efektivitas dan bila perlu menambahkan langkah perbaikan.

3.4 Butir 1.35 (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Setiap penyimpangan terhadap SPO, proses tervalidasi, atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi atau persyaratan lain yang terkait mutu harus dicatat dan diselidiki. Dampak yang potensial terhadap mutu produk yang menyimpang, atau terhadap produk lainnya, kejadian tidak diinginkan dan reaksi yang tidak diinginkan seharusnya dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan dan pencegahan keberulangan. Validitas dan tingkat kecacatan mutu yang dilaporkan harus dinilai berdasarkan prinsip MRM untuk mendukung keputusan terkait derajat penyelidikan dan tindakan yang diambil.

3.5 Butir 1.36 (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Seharusnya terdapat prosedur untuk memberi tahu penanggung jawab secara tepat waktu tentang kekurangan, penyimpangan, atau ketidakpatuhan terhadap komitmen regulatori (misalnya dalam tanggapan terhadap inspeksi regulatori), cacat pada komponen atau produk, atau kesalahan pengujian dan tindakan terkait (misalnya keluhan terkait mutu, penarikan kembali, tindakan regulatori, dll). Keputusan untuk menarik atau tidak menarik harus berbasis risiko dan didokumentasikan.

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN		Halaman : 3 dari 11 Nomor : UDDP-MK-L2-004 Versi : 004 Tgl. berlaku : 15 Sep 2025 Tgl. kaji ulang : 15 Sep 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

3.6 Butir 1.37 (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Manajemen puncak dan Penanggung Jawab harus diberitahu secara tepat waktu tentang kejadian serius yang tidak diinginkan, penyimpangan yang signifikan, dicatat pada komponen atau produk yang serius. Sumber daya yang memadai untuk penyelesaian secara tepat waktu harus tersedia.

3.7 Butir 1.38 (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Penyebab penyimpangan yang kritis dan proses yang kemungkinan berkaitan dengan penyimpangan harus dievaluasi secara berkala. Pengkajian dan persetujuan kelengkapan penyelidikan sampai tuntas, termasuk verifikasi efektivitas sebagai tindakan perbaikan dan pencegahan, harus didokumentasikan untuk mengidentifikasi masalah sistematis yang memerlukan tindakan perbaikan yang tepat.

3.8 Butir 1.39 (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Investigasi harus mencakup tinjauan laporan sebelumnya atau informasi relevan lainnya untuk indikasi masalah spesifik atau berulang yang memerlukan perhatian dan kemungkinan tindakan-regulatori lebih lanjut. Proses dan data yang relevan harus dipantau dengan maksud untuk mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari potensi penyimpangan terjadi di masa depan. Bila perlu, metode statistik atau sarana lain seharusnya digunakan untuk menilai dan memantau kemampuan proses. Informasi yang komprehensif tentang sifat dan tingkat cacat mutu mungkin tidak selalu tersedia pada tahap awal investigasi, proses pengambilan keputusan seharusnya tetap memastikan bahwa tindakan pengurangan risiko yang tepat diambil pada waktu yang tepat selama investigasi tersebut.

3.9 Butir 1.40 (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Tingkat analisis akar penyebab yang tepat seharusnya diterapkan selama penyelidikan penyimpangan sesuai butir 1.35.

3.10 Butir 1.41 (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Keputusan yang dibuat selama dan setelah investigasi harus mencerminkan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh penyimpangan tersebut secara keseriusan dari setiap ketidakpatuhan sehubungan dengan persyaratan spesifikasi komponen darah atau Cara Pembuatan yang Baik. Keputusan tersebut harus tepat waktu untuk memastikan keselamatan pasien, dengan cara yang tepat sesuai dengan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh masalah tersebut.

3.11 Butir 1.42 (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Semua penyimpangan dan ketidaksesuaian seharusnya dimasukkan ke dalam suatu sistem yang dievaluasi sesuai butir 1.35 dan 1.40 untuk penelusuran dan pembuatan tren data yang memudahkan perbaikan proses.

3.12 Butir 1.43 (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Penanganan penyimpangan dan ketidaksesuaian harus ditetapkan secara tertulis. Tindakan dalam jangka waktu yang wajar perlu diambil untuk menghindari dampak pada prdoduk lain yang diolah di unit yang sama.

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN		Halaman : 4 dari 11 Nomor : UDDP-MK-L2-004 Versi : 004 Tgl. berlaku : 15 Sep 2025 Tgl. kaji ulang : 15 Sep 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

3.13 Butir 1.44 (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Dalam keadaan tertentu, suatu produk mungkin dapat diluluskan setelah dilakukan evaluasi penyimpangan. Dokumentasi mencakup kajian risiko dan alasan pelulusan produk yang menyimpang dari persyaratan dan seharusnya ditandatangani oleh Kepala Bagian Pelayanan Darah dan disetujui Penanggung Jawab Pemastian Mutu/Penanggung Jawab Mutu.

3.14 Butir 4.47 (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Jika ditemukan penyimpangan atau masalah, maka harus dilakukan tindakan untuk identifikasi, penentuan prioritas, perencanaan dan pelaksanaan.

3.15 Butir 5.18 (Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025)

Hasil yang tidak memenuhi kriteria keberterimaan yang telah ditentukan harus dicatat sebagai penyimpangan dan diinvestigasi secara menyeluruh sesuai prosedur internal. Setiap implikasi terhadap validasi harus dibahas dalam laporan.

3.16 Setiap kesalahan, insiden, ketidaksesuaian, kegagalan, penyimpangan dan lainnya harus segera didokumentasikan dan diinvestigasi terhadap akar penyebab masalahnya. Tindakan perbaikan harus segera diambil untuk memperbaiki segera masalah ini, kemudian ditentukan juga tindakan perbaikan dan pencegahannya (TPP) agar tidak berulang di masa yang akan datang.

3.17 Masa penyelesaian Insiden:

- | | | |
|--------|---|---|
| 3.17.1 | Insiden sangat rendah
(<i>insignificant</i>) | : Tindakan perbaikan dilakukan pada saat itu juga |
| 3.17.2 | Insiden rendah
(<i>minor</i>) | : Tindakan dilakukan jika diperlukan dan dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan ketentuan yang sudah ada |
| 3.17.3 | Insiden sedang
(<i>moderat</i>) | : 6 minggu sejak tanggal TPP dimulai |
| 3.17.4 | Insiden tinggi (<i>mayor</i>) | : 4 minggu sejak tanggal TPP dimulai |
| 3.17.5 | Insiden sangat tinggi
(<i>kritikal</i>) | : 2 minggu sejak tanggal TPP dimulai |

4 Referensi

- 4.1 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah
- 4.2 Peraturan BPOM No. 11 tahun 2025 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik di Unit Pengelola Darah (UPD) dan Bank Plasma

5 Definisi dan Singkatan

- 5.1 Insiden adalah penyimpangan terhadap semua kejadian yang tidak direncanakan ataupun pada kondisi tertentu diprediksi akan terjadi potensi penyimpangan selama dan/atau sesudah proses pengolahan komponen darah

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN		Halaman : 5 dari 11 Nomor : UDDP-MK-L2-004 Versi : 004 Tgl. berlaku : 15 Sep 2025 Tgl. kaji ulang : 15 Sep 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

- 5.2 TPP adalah Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (*Corrective and Preventive Action*)
- 5.3 Sangat rendah (*insignificant*) adalah ketidaksesuaian yang berdampak kecil sehingga tidak perlu dilakukan tindakan atau *monitoring*
- 5.4 Rendah (*minor*) adalah ketidaksesuaian yang tidak berdampak pada produk namun terkait dengan ketidaksesuaian terhadap standar atau SPO. Signifikasi dari ketidaksesuaian minor mungkin hanya menjadi perhatian bagi pihak terkait internal
- 5.5 Sedang (*moderate*) adalah ketidaksesuaiaan yang berdampak pada produk namun terkait dengan ketidaksesuaian terhadap standar atau SPO. Signifikansi dari ketidaksesuaian sedang, menjadi perhatian bagi pihak terkiat internal
- 5.6 Tinggi (*mayor*) adalah ketidaksesuaian yang mungkin dapat membuat sebuah produk tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan atau potensial dapat mengakibatkan efek samping pada penerima produk
- 5.7 Sangat tinggi (kritikal) adalah ketidaksesuaian yanag berefek secara signifikan terhadap keamanan, efikasi serta kualitas dari sebuah produk dan berpotensi dapat menimbulkan kesalahan yang fatal dan memerlukan perbaikan segera
- 5.8 Pelapor adalah pihak yang melaporkan terhadap hasil temuan ketidaksesuaian
- 5.9 Responder adalah pihak yang merespon hasil temuan ketidaksesuaian, mencari akar penyebab dan melakukan penanganan
- 5.10 Otorisasi Regulatori Nasional atau disingkat menjadi ORN merupakan instansi atau badan milik pemerintah yang berperan sebagai pembuatan kebijakan atau pengawas pelaksanaan pelayanan darah misalnya BPOM, Kementerian Kesehatan, dll.
- 5.11 Pihak ketiga diartikan sebagai pihak lain di luar ORN (BPOM, Kemenkes, dll) yang terdampak dari penyimpangan yang terjadi misalnya pihak Fraksionator, dll.
- 5.12 Status “Karantina” adalah penyimpanan sementara komponen darah, BHP (Bahan Habis Pakai) ataupun barang di suhu tertentu untuk diselidiki penyebab insiden hingga dapat ditentukan statusnya
- 5.13 Status “Tarik” adalah proses penarikan komponen darah, BHP ataupun barang di suhu tertentu yang mengalami penyimpangan sehingga tidak dapat digunakan sesuai standar
- 5.14 Status “Buang” adalah tindakan yang dilakukan setelah dilakukan penarikan komponen darah, BHP atau barang di suhu tertentu yang mengalami penyimpangan
- 5.15 Status “Rilis” adalah tindakan yang dilakukan untuk merilis komponen darah, BHP ataupun barang di suhu tertentu setelah dinyatakan layak untuk digunakan

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN		Halaman : 6 dari 11 Nomor : UDDP-MK-L2-004 Versi : 004 Tgl. berlaku : 15 Sep 2025 Tgl. kaji ulang : 15 Sep 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

6 Peran dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung Jawab
Manajer Kualitas	- Mengesahkan SPO Pelaporan dan Penanganan Insiden - Memberikan persetujuan laporan insiden dan rencana perubahan untuk insiden mayor dan kritikal - Melakukan tinjauan manajemen terhadap Laporan Insiden, Rencana Perubahan dan TPP yang disusun bersama dengan Kepala Sub Bidang Kontrol Dokumen, Kepala Bidang Pemastian Mutu, dan Kepala Bidang yang terkait - Memberikan persetujuan untuk penutupan laporan insiden apabila TPP dan rencana perubahan telah dilakukan
Kepala Sub Bidang Pemastian Mutu	- Memastikan bahwa semua tindakan perbaikan dan pencegahan telah diambil - Mengkaji ulang kelengkapan dan kesesuaian laporan bersama dengan Manajer Kualitas
Kepala Sub Bidang Kontrol Dokumen	- Menyediakan formulir dan nomor registrasi pelaporan dan penanganan insiden - Berkoordinasi dengan bidang terkait untuk pembuatan laporan - Memutuskan apakah memerlukan pencatatan TPP
Kepala Bidang	- Melakukan investigasi bersama dengan petugas di masing-masing bidang atau bidang terkait lainnya sesuai dengan jenis penyimpangannya - Menunjuk penanggung jawab investigasi untuk pelaporan dan penanganan insiden - Menominasikan ketua dan tim pencatatan TPP (apabila diperlukan) bersama dengan Manajer Kualitas untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan oleh Kepala UDDP - Ikut serta dalam melakukan rapat tinjauan manajemen terhadap Laporan Insiden, Rencana Perubahan dan TPP yang disusun - Menganalisis penilaian dampak risiko bersama dengan pelapor/investigator
Responder (Penanggung jawab terkait)	- Dinominasikan oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab untuk melalui masalah yang ditemukan - Melakukan investigasi terhadap akar penyebab - Melakukan penilaian dampak risiko bersama dengan Kepala Bidang terkait

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN		Halaman : 7 dari 11 Nomor : UDDP-MK-L2-004 Versi : 004 Tgl. berlaku : 15 Sep 2025 Tgl. kaji ulang : 15 Sep 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Peran	Tanggung Jawab
	• Memberitahukan Manajer Kualitas dan Kepala UDDP dengan segera jika hasil penilaian dampak berupa Mayor atau Kritis • Melakukan tindakan perbaikan segera terhadap komponen yang terkait • Menentukan tindakan yang sesuai dan lengkapi Rencana Perubahan jika diperlukan • Memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan dan konfirmasi tindakan perbaikan telah lengkap
Reporter/Pelapor (Petugas/Kepala Bidang yang menemukan insiden)	• Melaporkan insiden kepada Kepala Bidang terkait dan Manajer Kualitas • Meminta formulir dan nomor registrasi pelaporan dan penanganan insiden kepada Sub Bidang Kontrol Dokumen • Membuat Laporan Insiden

7 Prosedur

- 7.1. Identifikasi terjadinya insiden dan melaporkan secara lisan oleh petugas kepada Kepala Bidang bersangkutan, Kepala Bidang segera menghentikan kegiatan yang terkait jika insiden berupa mayor/kritis
- 7.2. Pisahkan produk atau identifikasi bagian yang terkait insiden. Apabila insiden berdampak pada produk, maka beri tanda status yang jelas pada produk misalnya status: "Karantina"
- 7.3. Isi formulir pelaporan dan penanganan insiden
 - 7.3.1 Dapatkan nomor registrasi Laporan Insiden dari Sub Bidang Kontrol Dokumen
 - 7.3.2 Lengkapi Kegiatan 1. Pelaporan Insiden pada Formulir Pelaporan dan Penanganan Insiden, yang menjelaskan:
 - Tanggal dan waktu insiden dan Bidang tempat terjadinya insiden ditemukan
 - Proses apa yang ditunjukkan ketika insiden ditemukan (jika ada)
 - Apa yang terjadi dan tindakan perbaikan apa yang telah diambil
- 7.4. Beri tanda tangan dan tanggal pada kolom di Kegiatan 1 oleh Pelapor
- 7.5. Serahkan Laporan Insiden ke Kepala Bidang terkait yang harus menyelesaikan dan merespon masalah atau insiden yang ada lalu lengkapi nama Kepala Bidang penerima laporan dan tanggal pengiriman laporannya
- 7.6. Lakukan evaluasi dan penelusuran penyebab insiden dengan berbagai cara untuk mendapatkan akar penyebab dari penyimpangan
- 7.7. Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang menetapkan atau menunjukkan apakah memerlukan Pencatatan TPP atau tidak sebelum menunjuk seorang Responder dan Pimpinan TPP

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN		Halaman : 8 dari 11 Nomor : UDDP-MK-L2-004 Versi : 004 Tgl. berlaku : 15 Sep 2025 Tgl. kaji ulang : 15 Sep 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

- 7.7.1. Catat tanggal terima dan nama bidang penerima laporan insiden oleh Kepala Bidang
- 7.7.2. *Review Kegiatan 2* untuk menetapkan tingkat signifikansi dari insiden
- 7.7.3. Nominasi Responder jika insiden yang ditemukan hanya melibatkan 1 (satu) bidang saja lalu catat nama responder yang telah ditetapkan
- 7.7.4. Nominasi Pimpinan TPP dan timnya jika:
 - Investigasi dan rencana TPP diperlukan jika insiden yang terjadi itu kompleks dan melibatkan banyak bidang
 - Permasalahan yang terjadi dirasa tidak serius, namun terus berulang terjadi sehingga dapat berdampak serius
 - Data atau pengawasan yang menunjukkan adanya kecenderungan terjadinya permasalahan serius, dimana belum terjadi, namun berpotensi terjadi di masa yang akan datang
- 7.7.5. Apabila TPP diperlukan, maka catat nomor registrasi pencatatan TPP yang diperoleh dari Sub Bidang Kontrol Dokumen, dan lampirkan Formulir Pelaporan dan Penanganan Insiden (yang sudah dilengkapi sampai Kegiatan 2) pada Formulir Pencatatan TPP untuk selanjutnya pencatatan terkait insiden dilakukan di Formulir Pencatatan TPP sehingga tidak ada tindak lanjut pada Formulir Pelaporan dan Penanganan Insiden
- 7.7.6. Beri tanda tangan dan tanggal oleh Kepala Bidang
- 7.8. **Penilaian Dampak**

Penilaian dampak dan tindakan terhadap objek yang terdampak yang dilakukan oleh Responder terpilih/Kepala Bidang

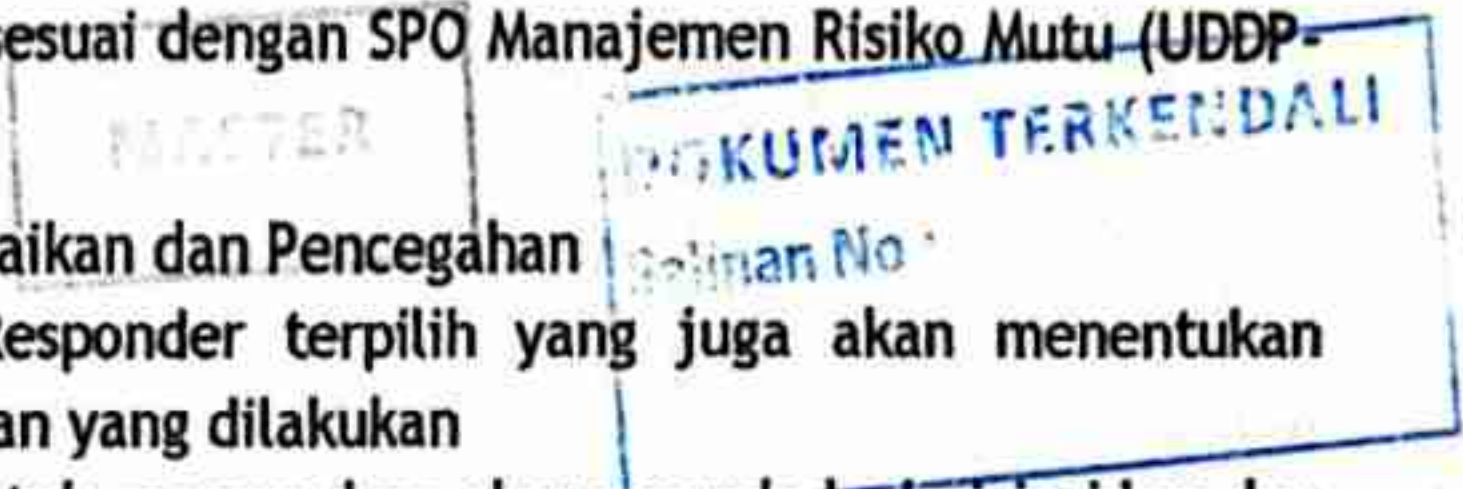
 - 7.8.1. Lengkapi Kegiatan 3. Penilaian Dampak pada Formulir Pelaporan dan Penanganan insiden
 - 7.8.2. Nilai dampak dari insiden dengan menggunakan Tabel Risiko pada Kegiatan 3 dan tentukan tingkat keparahan dari insiden dan cara penemuannya
 - 7.8.3. Beritahukan kepada Kepala UDDP dan Manajer Kualitas sesegera mungkin jika hasil penilaian dampak berupa “mayor” atau “kritis” dan beri ceklis pada kotak “Ya ☐” lalu catat tanggal diberitahukannya
 - 7.8.4. Beritahukan kepada Pihak Ketiga sesegera mungkin jika hasil penilaian dampak berupa “kritis”
 - 7.8.5. Tentukan perbaikan sesuai dengan penilaian dampak terhadap objek tersebut. Apabila objek yang terdampak adalah komponen darah, maka tindakan yang diambil yaitu:
 - Konfirmasi dan catat jumlah dan jenis komponen darah yang terkena dampak
 - Tentukan tindakan:
 - Karantina komponen darah (biasanya dilakukan sesegera mungkin dan ketika penilaian dampak sedang bertanggung jawab)

MASTER

DAFTAR KENDALI
TERKENDALI
 Dokumen No.

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN		Halaman : 9 dari 11 Nomor : UDDP-MK-L2-004 Versi : 004 Tgl. berlaku : 15 Sep 2025 Tgl. kaji ulang : 15 Sep 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

- Tarik komponen terkait yang mengalami penyimpangan (jika sudah dirilis ke Rumah Sakit)
 - Buang komponen terkait yang mengalami penyimpangan
 - Rilis komponen terkait yang telah dinyatakan layak untuk digunakan (alasan yang mendukung penggunaan komponen itu harus ditulis dalam laporan)
 - Beri ceklis pada kotak "□" tindakan yang diambil
- 7.8.6. Catat tanggal tindakan selesai dilakukan dan beri tanda tangan sebagai konfirmasi bahwa tindakan perbaikan terhadap komponen telah dilakukan
- 7.8.7. Pastikan bahwa Kegiatan 3 telah dilengkapi
- 7.8.8. Lakukan kajian risiko sesuai dengan SPO Manajemen Risiko Mutu (UDDP-MK-L2-002)
- 7.9. Investigasi dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Investigasi dilakukan oleh Responder terpilih yang juga akan menentukan tindakan perbaikan pencegahan yang dilakukan
- 7.9.1. Lakukan investigasi untuk menemukan akar penyebab dari insiden dan lengkapi kolom pertama Kegiatan 4. Investigasi dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan pada Formulir Pelaporan dan Penanganan Insiden
- 7.9.2. Sisipkan salinan dokumen atau bukti lainnya jika diperlukan
- 7.9.3. Tentukan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP) yang akan diambil untuk memperbaiki masalah saat ini dan mencegah terulangnya kembali di masa yang akan datang. Lengkapi kolom kedua dari Kegiatan 4
- 7.9.4. Apabila Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP) akan melibatkan perubahan mayor, lengkapi Formulir Rencana Perubahan (UDDP-MK-L4-008) dan merujuk kepada SPO Pengendalian Perubahan (UDDP-MK-L2-003). Beri ceklis pada kotak "Ya □" lalu masukkan Nomor Rencana Perubahan pada Formulir Pelaporan dan Penanganan Insiden
- 7.9.5. Dapatkan persetujuan untuk rencana Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP) dari Manajer Kualitas apabila hasil penilaian dampak berupa mayor atau kritis dan catat tanggal persetujuannya. Apabila dampak berupa minor, tandai dengan N/A
- 7.9.6. Pastikan bahwa Kegiatan 4 telah dilengkapi
- 7.10. Penyelesaian Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP)
Responder mengkonfirmasi bahwa semua Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP) telah dilakukan dan semua dokumentasi telah lengkap
- 7.10.1. Lengkapi kolom kesimpulan dari tindakan yang diambil di Kegiatan 5 pada Formulir Pelaporan dan Penanganan Insiden
- 7.10.2. Sisipkan bukti penyelesaian TPP
- 7.10.3. Jika terdapat rencana perubahan, lengkapi dan sisipkan Formulir Rencana Perubahan pada Pelaporan dan Penanganan Insiden
- 7.10.4. Beri tanda tangan dan tanggal pada kolom di Kegiatan 5



 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN		Halaman : 10 dari 11 Nomor : UDDP-MK-L2-004 Versi : 004 Tgl. berlaku : 15 Sep 2025 Tgl. kaji ulang : 15 Sep 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

- 7.10.5. Periksa laporan secara keseluruhan untuk konfirmasi kelengkapan
- 7.10.6. Ajukan kepada Manajer Kualitas untuk persetujuan penutupan laporan insiden

7.11. Penutupan Laporan

Setujui dan tandatangani Formulir Pelaporan dan Penanganan Insiden (UDDP-MK-L4-010) oleh Manajer Kualitas atau orang yang diberi wewenang setelah melakukan:

- 7.11.1. Review Formulir Pelaporan dan Penanganan Insiden dan bukti untuk kelengkapan dan kesesuaian laporan
- 7.11.2. Review untuk mengecek kelengkapan dan kesesuaian jika terdapat rencana perubahan
- 7.11.3. Beri ceklis pada kotak “Ya ☐” disetujui untuk ditutup
- 7.11.4. Beri komentar jika ada
- 7.11.5. Tandatangani Formulir Pelaporan dan Penanganan Insiden dan Formulir Rencana Perubahan jika sudah sesuai dan lengkap
- 7.11.6. Perbaharui Daftar Registrasi Pelaporan dan Penanganan Insiden dan Registrasi Rencana Perubahan, dan Formulir Registrasi Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (TPP) jika digunakan
- 7.11.7. Pastikan bahwa laporan insiden ini telah terdaftar
- 7.11.8. Laporkan hasil akhir Laporan Insiden, Rencana Perubahan dan TPP pada Manajemen menggunakan Laporan Tinjauan Manajemen

8 Dokumen Terkait

- 8.1 SPO Manajemen Risiko Mutu (UDDP-MK-L2-002)
- 8.2 SPO Pengendalian Perubahan (UDDP-MK-L2-003)
- 8.3 SPO Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (UDDP-MK-L2-005)

9 Lampiran

- 9.2 Registrasi Rencana Perubahan (UDDP-MK-L4-009)
- 9.3 Formulir Pelaporan dan Penanganan Insiden (UDDP-MK-L4-010)
- 9.4 Formulir Pencatatan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (UDDP-MK-L4-011)
- 9.5 Daftar Registrasi Pelaporan dan Penanganan Insiden (UDDP-MK-L4-038)

10 Riwayat Perubahan

Versi	Tanggal Berlaku	Referensi	Kesimpulan perubahan
001	20 Januari 2021	PerKa No 10 tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di Unit Transfusi Darah (UTD) dan Pusat Plasmaferesis	Dokumen baru

 Palang Merah Indonesia UNIT DONOR DARAH PUSAT	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PELAPORAN DAN PENANGANAN INSIDEN		Halaman : 11 dari 11 Nomor : UDDP-MK-L2-004 Versi : 004 Tgl. berlaku : 15 Sep 2025 Tgl. kaji ulang : 15 Sep 2027
	Bidang Manajemen Kualitas	Sub Bidang Kontrol Dokumen	

Versi	Tanggal Berlaku	Referensi	Kesimpulan perubahan
002	17 Februari 2023	PerKa No 10 tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di Unit Transfusi Darah (UTD) dan Pusat Plasmaferesis CPOB	- Perubahan tanggal berlaku dan kaji ulang - Revisi hasil investigasi BPOM
003	26 Maret 2025	PerKa No 10 tahun 2017 BPOM tentang Pedoman CPOB di Unit Transfusi Darah (UTD) dan Pusat Plasmaferesis MASTER DOKUMEN TERKENDALI Revisi No. 1	- Menyisipkan poin pengkajian manajemen risiko sesuai dengan SPO Manajemen Risiko - Perubahan kata” Direktur” menjadi” Kepala” - Perubahan kalimat dalam peran dan tanggung jawab sesuai dengan format yang berlaku - Perubahan struktur organisasi - Penamabahan Peran dan Tanggung jawab dengan menambahkan yang diberi wewenan sebagai Pj Kepala dan Manajer Kualitas
004	15 September 2025	Peraturan BPOM No. 11 Tahun 2025 tentang Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik di UPD dan Bank Plasma	- Perubahan persyaratan sistem mutu sesuai dengan aturan yang berlaku - Penambahan prosedur terkait dengan pemberian pemberitahuan/notifikasi pada pihak ketiga dan ORN jika terjadi penyimpangan kritikal